中国语言康复业发展现状及路径选择*

戈兆一[1]，李宇明[2]

（1. 首都师范大学　中国语言产业研究院　北京　100048；

2. 北京语言大学　语言科学与资源学院语言政策与标准研究所　北京　100083）

提　要　语言康复业是语言产业的行业形态之一，也属于大健康产业。应建构符合大健康理念、面向全人群全生命周期、突破传统听力与言语康复行业界限的大语言康复业。语言康复业面向语言障碍弱势人群，兼具“事业”“产业”双重属性，提供的语言康复产品（服务）既有语言商品，也有语言福利。目前中国语言康复产业的市场规模超过 300 亿元，供需缺口、市场潜力巨大，成长空间可达数千亿元。语言康复业现状远不能满足数千万语言障碍者的康复需求，需要重塑行业认知，健全人力资源体系，完善福利政策。本文建构了语言康复业生态系统，认为语言健康是国民健康的重要方面，语言康复供给能力亦应成为国家语言能力的构成因素，“人人享有语言健康”应成为“健康中国”的建设目标。

关键词　语言产业；语言康复业；供需状况；市场规模；发展策略

中图分类号　H002　**文献标识码**　A　**文章编号**　2096-1014（2026）01-0029-13

DOI　10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20260103

The Language Rehabilitation Industry in China: Current Development and Strategic Outlook

Ge Zhaoyi and Li Yuming

Abstract　The language rehabilitation industry represents a specialised sector within both the broader language industry and the Greater Health industry. There is a need to develop a “Greater Language Rehabilitation Industry” that aligns with the principles of Greater Health, serves the entire population throughout the life span, and transcends the traditional confines of hearing and speech rehabilitation. Focusing on individuals with language disorders, the language rehabilitation industry possesses dual characteristics: it functions as both a public good and an industry, offering products and services that span language commodities and language welfare. Currently, the market size of China’s language rehabilitation industry exceeds 30 billion RMB, yet a substantial gap between supply and demand persists, indicating a significant market potential that could reach several hundred billion RMB. The industry’s current capacity falls short of meeting the rehabilitation needs of the tens of millions of people affected by language disorders. Addressing this critical issue requires dedicated efforts in three key areas: redefining industry perception, strengthening the human resource system, and enhancing welfare policies. This paper constructs an ecosystem framework for the language rehabilitation industry and argues that language health is an essential component of

*　作者简介：戈兆一，男，首都师范大学在读博士研究生，主要研究方向为语言产业。电子邮箱：gezhaoyi@sina.com。李宇明（通讯作者），男，北京语言大学教授，主要研究方向为语言政策与规划、儿童语言学、语法学。电子邮箱：p55066@blcu.edu.cn。

国家语委委托项目“中国语言产业发展报告”，国家语委重点项目“中国语言产业数据库建设及应用研究”（ZDI145-33），国家社科基金重大项目“两个一百年”背景下的语言国情调查与语言规划研究（21&ZD289）。

中国知网　https://www.cnki.net

national health, without which individual well-being and happiness are difficult to achieve. Furthermore, the capacity to provide language rehabilitation services should be regarded as an integral aspect of a nation's language competence. Achieving "language health for all" should be recognised as a shared goal within the broader "Healthy China" initiative.

Keywords language rehabilitation industry; language industry; supply-demand dynamics; market scale; development strategies

一、引 言

语言康复研究早年来自临床医学，聚焦于语言障碍诊断治疗、语言康复技术与方法等。随着语言康复教育事业的发展，学科专业建设和人才培养的研究也有所开展，但行业与管理方面的研究尚少有见到。知网文献显示，中国语言康复研究发端于 20 世纪 90 年代听力言语康复的相关研究，随后，因疾病引发的语言障碍（如脑卒中后的失语症）的康复研究开展起来。21 世纪特别是近 10 年来，密切相关的研究有临床语言学（朱祖德，等 2020）、语言病理学（王欢 2021）、老年语言学（顾曰国 2019；周德宇，等 2020；黄立鹤，等 2024）、语言与健康（马文，等 2023，2025）等。涉及行业与管理的博士论文有两篇：《听障儿童语言康复对策研究》（程凯 2007）、《关于中国语言障碍者语言政策的调查研究》（刘晓宇 2024）。中国听力医学发展基金会发布过《中国听力健康报告（2021）》（中国听力医学发展基金会 2021）。

语言康复业是语言产业的典型业态之一，已有学者从供需关系、产品消费、市场细分和经济规模等方面对语言康复行业进行了初步探讨（贺宏志 2013；李艳 2017；李艳，汪梦尧 2024）。随着国家对语言产业关注度的逐步提高和语言康复行业自身发展的需要，社会管理层面的研究也应受到重视。本文拟在《中国语言产业发展报告》对语言康复业进行调查的基础上，厘清行业界定，全面梳理产品构成、供需状况与市场规模，并分析其发展环境与策略。

语言康复，指通过对语言障碍进行诊断、评估和积极干预，使语言障碍者的语言能力得以恢复或部分恢复。语言障碍可能在所有人群中发生，因此，语言康复应是面向全人群、全生命周期的，其重点人群是残障人群、老年人群、少儿人群（含婴幼儿）等。《中华人民共和国残疾人保障法》界定，"残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人"，除肢体残疾外，其他 6 类都可能导致语言障碍。由上述各种残疾和一些疾病（如脑卒中、阿尔茨海默病等老年病，自闭症等儿童疾病，唇腭裂等新生儿疾病）所致的语言障碍达 20 种左右。学界对语言障碍有不同的分类，如单春雷（2021）将语言障碍区分为发展性语言障碍、获得性语言障碍、痴呆性语言障碍。发展性语言障碍指儿童语言障碍，如儿童语言发育迟缓；获得性语言障碍最常见的是失语症；痴呆性语言障碍多见于老年期。[①] 不同的分类采用的分类标准不同，且各有各的作用。

语言康复业是语言康复产品（包括语言康复服务）的所有供需、产销活动的集合，其任务是满足语言障碍人群的诊疗、评估与康复的各种需求，也属于大健康产业。语言康复业可从需求主体、供给目标、行业性质 3 个方面加以分析。

① 以上是对语言障碍的广义理解，泛指个体在语言符号系统（理解、表达、逻辑处理）及口语生成（发音、语流、嗓音）等维度中出现的综合功能异常，强调听、说、读、写及沟通等语言能力的整体受损。狭义的语言障碍仅指前者，即个体在语言符号系统的理解、表达及逻辑处理层面的异常；而后者被称之为言语障碍（speech impairment），专指口语生成的物理性异常。所以，广义的语言障碍包含言语障碍和狭义的语言障碍，临床上将两者并列，严格区分。言语–语言障碍（speech-language disorder）这一术语则用于临床上表达患者同时存在言语障碍与狭义语言障碍的双重情形。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）需求主体。需求主体包括语言障碍人群及其家属、相关者，康复从业人员及相关管理人员。语言障碍人群因语言功能受损而不具有正常的语言能力，在语言生活、经济生活、文化生活等方面处于弱势地位。语言障碍人群是显性需求主体，其家属、相关从业人员及相关管理人员等是隐性需求主体，隐性需求者常被忽视。

（2）供给目标。语言康复旨在恢复或部分恢复语言障碍人群的语言能力，或辅助其进行语言活动，从而使其拥有合理的语言权益，以获得平等参与社会生活的机会。

（3）行业性质。由于需求主体、供给目标的特殊性，语言康复业兼具市场性和福利性，具有“事业”“产业”的双重属性。市场性是指语言康复产品（服务）买卖双方的交易活动，卖方以营利为目的，为买方提供需要付费的产品，其供给主体主要是语言康复企业。福利性是指语言康复产品（服务）具有公共产品性质，其供给主体主要是政府部门、事业单位和社会组织，他们购买语言康复产品，提供给语言障碍人群，这种语言福利是社会福利的组成部分。所以，语言康复业既生产、销售具有营利性质的语言商品，又提供具有语言福利性质的公共语言产品。

二、中国语言康复业的发展脉络

中国语言康复业是在20世纪80年代随着康复医学的兴起而发展起来的，一批临床医院、医学院校和研究机构陆续开展语言治疗、教学和科研工作。主要发展脉络如下。

（一）残疾人事业和特殊教育的发展

中国进行过两次全国残疾人抽样调查（1987，2006）。[①] 第一次抽样调查时，发现有2290万听力语言残疾人；第二次抽样调查时，因听力语言残疾人数众多，便将听力语言残疾类别划分为听力残疾和言语残疾。第二次调查结果显示，全国各类残疾人总数为8296万，其中听力残疾2004万，言语残疾127万，多重残疾1352万（内含听力残疾776万，占比57.4%），单纯听力残疾和多重残疾中兼患听力残疾者共计2780万。[②] 听是说的基础，因此听障人群几乎都存在不同程度的语言障碍。视力残疾会导致阅读障碍和书写障碍，智力残疾和精神残疾也常伴有不同程度的语言障碍。语障人群面临着出行困难、受教育机会少、劳动就业难、社会流动不易、获取社会信息不畅、社会权利不平等等多重困难，亟待语言康复。

为满足残疾人康复、生活、教育、就业等多重需求，促进残疾人事业与经济、社会协调发展，中国残疾人联合会于1988年成立，国务院首次批转残疾人事业发展专项规划《中国残疾人事业五年工作纲要（1988—1992）》；此后相继颁布《中华人民共和国残疾人保障法》（1990）、《残疾人教育条例》（1994）、《残疾人就业条例》（2007）、《残疾预防和残疾人康复条例》（2017）等。1988年制定的《全国残疾人三项康复工作实施方案》，要求立即着手实施的3项康复工作之一就是聋儿听力语言训练，中国语言康复基础工作由此起步并不断发展，特别是两期特殊教育提升计划（2014，2017），对接收听障儿童的普通学校和特殊教育学校均提出明确要求，学龄段听障儿童经过早期干预与康复服务，多数可进入普通学校接受融合教育，提升了中国听力残疾、言语残疾儿童融合教育的质量。

① 以2006年第二次全国残疾人抽样调查为例：调查由国务院批准成立的全国残疾人抽样调查领导小组主持，该领导小组由多部门负责人组成，实行全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责的组织机制。调查采用抽样方法。调查内容包括残疾人数量、结构、分布、致残原因及生活状况等。调查在全国抽样近260万人，对象为常住人口。

② 第二次全国残疾人抽样调查领导小组，中华人民共和国国家统计局，《2006年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报》（第一号），https://www.cdpf.org.cn//zwgk/zccx/dcsj/9ff8c67574af479dabaf6ac21b5305f4.htm。

中国知网 https://www.cnki.net

手语和盲文是听障、视障人群在接受特殊教育时或日常生活中所使用的特殊语言符号系统。中国手语规范化始于1959年，从《聋哑人通用手语草图》到《聋哑人通用手语图》，再到《中国手语》，历经3个阶段的更新迭代。中国盲文规范化始于1953年，从《新盲字方案》到《汉语双拼盲文方案》，经历了两个设计与推广阶段。2015年和2021年，启动了两期国家手语和盲文规范化行动计划，制定了《国家通用手语常用词表》《国家通用盲文方案》。

国务院发布的《“十四五”残疾人保障和发展规划》，要求到2025年，对残疾人基本康复服务覆盖率、残疾人辅助器具适配率达到85%，这是一项约束性指标要求，并规划了一系列重点任务。[①]《“十四五”国民健康规划》提出“防盲治盲，推动实施全面眼健康行动”“防聋治聋，提升耳与听力健康水平”。[②]

（二）语言康复科学研究和专门人才培养

1983年，中国听力语言康复研究中心（原中国聋儿康复研究中心）成立，这是中国唯一一所国家级听力语言康复研究机构。作为全国听力语言康复工作的技术资源中心和行业管理机构，中心不仅致力于听力语言康复科学研究，还为不同年龄听障人群特别是听障儿童提供全面康复训练，为听障儿童的学前教育、融合教育、亲子教育和家长培训、咨询指导等提供服务，常年开展基层听力语言康复专业人员的在职培训。1988年，中国康复研究中心（北京博爱医院）成立，设听力语言科。从1990年开始，该中心开办全国听力语言康复培训班，接收来自全国的进修人员，普及语言治疗专业理念，将国外语言康复技术引入国内，累计培训学员数千人次，其中许多已成为中国语言治疗领域的专家骨干。

中国语言康复相关专业人才的培养经历了从无到有、不断壮大的发展历程。语言治疗师（speech-language pathologist，SLP）的培养工作始于20世纪90年代，初期主要是短期培训，现已形成学历教育和继续教育并举的人才培养格局，培养主体包括高校、医院、康复机构等。语言康复治疗已成为康复治疗的重要方向之一。语言康复专业教育初始于听力学，首都医科大学于2000年率先开设听力学本科教育。康复治疗学、特殊教育、护理学等相关学科的专业教育也培养相关人才。2016年，北京语言大学建立国内第一所语言康复学院。

在语言康复需求亟待满足、语言康复服务水平亟待提升的背景下，中国听力医学发展基金会（1995）、中国残疾人康复协会听力语言康复专业委员会（1992）及语言障碍康复专业委员会（2017）、中国康复医学会听力康复专业委员会（2006）及言语康复专业委员会（2020）等社会团体相继成立，致力于凝聚相关行业人士，开展语言康复科学研究和学术交流，推进中国语言康复业的健康发展。

（三）老龄事业的发展和“健康中国”的建设

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期中国的基本国情，积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务。《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（2019）和《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（2021）两份文件对老年康复工作做出了部署。老年人群是罹患语言障碍的高风险人群，衰老和生理、心理疾病可能直接或间接导致语言功能障碍，如因脑退化等老年病所导致的语言障碍，随着人口老龄化的加深势必不断增加。语言康复服务也是老年人群普遍性的基础需求。助听器、人工耳蜗等适老产品，手语、盲文等信息无障碍服务，这些年来在中国获得了很大程度的发展。《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（2024）要求大力推动助听器等传统功能代偿类康复辅助器具升级。《中华人民共和国无障碍环境建设法》（2023）规定“应当为

① https://www.cdpf.org.cn/zwgk/zcwj/wjfb/79b6ae39e38c4fa08ab03ad0f8f27b6b.htm.

② https://www.nirp.cn/fswsfgbz/fg/gfxwj/202502/W020250428529396345650.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

残疾人、老年人获取公共信息提供便利”，实现信息无障碍交流。语言无障碍是构建信息无障碍社会的重要基石，信息无障碍环境建设承担着满足人民美好生活需要的语言重任（李宇明 2022a，2022b）。在人口老龄化加剧的当下，语言资源的合理使用，可切实促进老龄友好型语言信息体系的建设，促进老年患者谈话疗法在疾病康复中的应用，促进老年患者生命关怀的医患沟通与医学人文教育等，为积极应对老龄化贡献力量（周德宇，张惟 2021）。

全民语言康复认知水平显著提高。健康中国建设体现“大健康”理念，以实现全民健康、全面健康、全生命周期健康为目标，强调做好未成年人、老年人、残疾人等特殊人群的健康工作。随着健康中国建设的推进和人民生活水平的提高，全社会对语言康复的重视程度也在提高，对语言与健康关系的认识也在深化。例如，针对语言能力衰退和语言蚀失，学界讨论如何在语言领域提升老年人群的幸福与健康指数，构建老年语言福利体系，促进“健康中国”建设（滕延江 2022）。

三、中国语言康复业的供需分析

（一）供给主体、需求主体状况

语言康复业供给主体由两类机构组成：（1）提供语言康复公共产品（服务）的机构，包括政府部门、残联组织、各级听力语言康复中心、医院（儿科、眼科、耳鼻喉科及康复科）、康复专科医院、特殊教育学校、高校有关学科专业、语言康复相关社会组织等，以公立为主；（2）提供市场、商品性质语言康复产品（服务）的单位，主要是指研发、生产、销售语言康复产品（服务）的企业组织，以民营为主。图 1 反映了两类机构的大体情况。

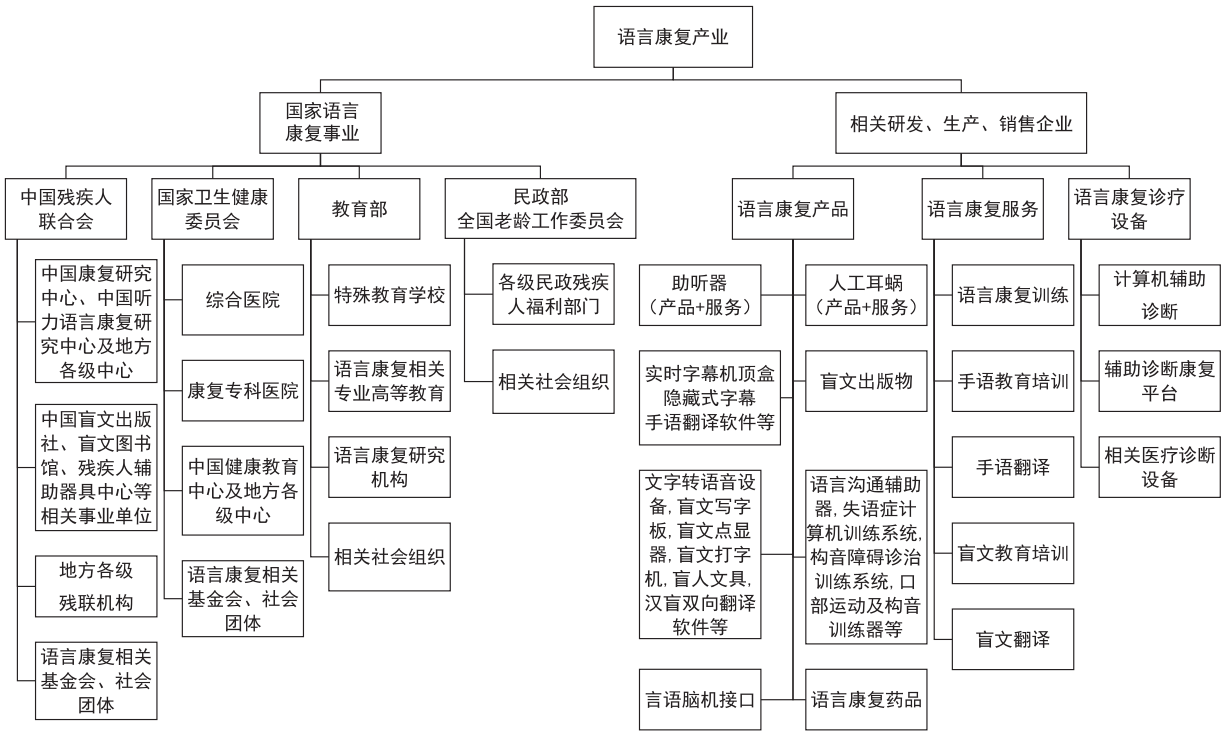

图 1　语言康复产业构成

中国知网　https://www.cnki.net

其中，语言康复专业教育的供给情况如下：国内听力学、语言康复专业教育分别起步于20世纪90年代和21世纪初。2012年开始，教育部正式批准“听力与言语康复学”和“教育康复学”进入本科专业目录，分属医学技术类、教育学类专业；“言语听觉康复技术”进入高职专科专业目录，属康复治疗类专业。2021年，高职本科专业目录新增“言语听觉治疗技术”。2016年，“手语翻译”进入本科专业目录，属中国语言文学类专业。目前有40余所院校开设了上述高等学历教育专业，并建立了相应的专业实验室和研究机构；有近200所高校开设“康复治疗学”本科专业，设置“语言治疗学”或“语言康复学”专业课程；有近20所高校开展手语语言学或盲文文字学研究，97所高校特殊教育专业开设手语和盲文课程。[①] 此外，还有一批医学、语言、师范类大学，在临床医学、中国语言文学等一级学科之下自设相关的二级学科，或者在有关二级学科之下开设听力学、言语康复、语言病理等研究方向。语言康复的本科教育、研究生教育、职业教育等正在快速发展。

语言康复业的需求主体，前文已经谈及，从个体和组织两个层面看，还可以分为个体需求和组织需求。个体需求主要表现为语言障碍者的诊断、评估、干预、治疗、康复等；组织需求主要指政府部门及相关事业单位政策供给、标准实施、语言康复福利、信息无障碍建设等。

（二）语言康复产品（服务）供需状况

1. 助听器与人工耳蜗

国家药品监督管理局官网[②] 文件显示，2015年至2025年7月，共颁发助听器产品注册证521张，当前在有效期的270张，分属120家生产企业，其中2022年注册达到最高峰（53张），显示市场进入活跃期。但有研究认为，中国助听器产品的市场渗透率仅约5%，还存在巨大的需求缺口（郭志强 2022）。

通过“企查查”检索（截至2025年7月），处于存续、在业状态的助听器相关企业共4599家（不含无注册资本的分公司），注册资本总量72亿元。生产企业之外，还有大量的助听器验配服务机构。

目前，中国重度/极重度听障人群近800万人。[③] 人工耳蜗植入需求每年都在增长，能开展人工耳蜗植入手术业务的医院已达200多家。1995年，中国大陆实现第一例多导人工耳蜗植入，截至2023年，已有超过12万名听障者通过人工耳蜗植入重获听觉能力。但也由此可见人工耳蜗产品的市场渗透率是极低的。[④]

国家药品监督管理局官网文件显示，至2025年7月，共颁发48张人工耳蜗产品注册证（有效期内），分属7家生产企业。通过“企查查”检索（截至2025年7月），处于存续、在业状态的人工耳蜗相关企业共57家，注册资本总量80亿元。前述研发生产企业之外，均为人工耳蜗直销、分销及相关机构，主要分布在北上广和江浙地区。

2. 以手语、盲文服务为代表的信息无障碍设备

中国现有聋人、盲人超过4000万人，[⑤] 加上其他类别语言障碍人群，直接关联人口达2亿之众，[⑥]

① 《〈语言文字报〉重点推出反映新时代手语盲文工作成就的文章》，https://www.cdpf.org.cn/xwzx/clyw2/5699a77e7f1143f18a7fcbf19c5d0453.htm。

② https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?3jfdxVGGVXFo=1766473296819#category=ylqx.

③ 根据孙喜斌等（2008）相关研究数据估算。

④ 《全国爱耳日：科技叩开“无声之门”》，新华社，2024-03-02，http://www.news.cn/tech/20240302/2169e0934d3541d6b6548560d8de76d7/c.html。

⑤ 《五年奋进！中国盲协助1700万视力残疾人逐梦新时代》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777804797952978591&wfr=spider&for=pc。《推倒一道道“玻璃墙”！中国聋协让2700万听力残疾人在无声的世界里“听见”爱》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777710583776781691&wfr=spider&for=pc。

⑥ 关联人口指的是与听力、视力残疾人及多重残疾人（含听力、视力残疾）语言生活直接（密切）关联的家人等人群。此处数据根据相关资料推算。

中国知网 https://www.cnki.net

对以手语服务、盲文服务为代表的信息无障碍设施设备、辅助交流仪器设备有着极大需求。达到规定的手语、盲文等级标准，成为从事视听残障教育的教师入职条件。“手语翻译”已列入《中华人民共和国职业分类大典（2022 年版）》，实施了手语翻译职业资格认证。

手语服务、盲文服务及其他无障碍服务的设备与设施，是无障碍环境建设的条件保障，是实现无障碍信息交流的重要支撑。国家制定了无障碍设施工程建设标准，规定应当保障残疾人、老年人无障碍信息交流和社会服务，提供无障碍网站、语音文字提示器、同步字幕、手语节目、盲文读物、有声读物、盲文试卷、盲文选票等无障碍设施设备，开展无障碍服务技能培训。科技创新加快赋能信息无障碍建设，信息科学、人工智能等高科技运用于手语识别与手语表达研究，以及明文与盲文之间、语音与盲文之间的识别与转换研究，涌现出很多新科技产品，如实时字幕机顶盒、盲用电脑、盲文点显器、盲文刻印机、听书机、手语翻译机等。手语数字人从北京冬奥会开始走入大众视野。可运用于手机端、PC 端、TV 端的读屏软件，是为视障人群设计的屏幕朗读软件，是帮助盲人上网的工具。中国盲文出版社是国内唯一为盲人服务的出版机构，致力于提供盲文书刊、有声读物、大字图书、无障碍影视、数字出版等产品。

通过“企查查”检索（截至 2025 年 7 月），处于存续、在业状态的手语服务相关企业共 70 家，注册资本总量 4.3 亿元。其中手语教学培训、手语翻译企业 37 家，手语软件研发企业 33 家。

3. 语言康复训练及仪器设备

中国言语残疾及伴有言语残疾的人数超过 3000 万，涉及听力障碍、唇腭裂、自闭症、脑瘫、发育迟缓、口吃、发音和构音障碍等各种类型的语言障碍患者（张凌云 2021），都需要通过语言康复训练来恢复或有限恢复语言能力。

截至 2020 年底，全国建成 31 家省级听力语言康复中心和 861 家基层康复中心，服务网络覆盖 90% 的地级市和 15% 的县级行政区，形成了以中国听力语言康复研究中心为指导中心、省级和地市级康复机构为骨干的服务网络，能够基本满足听障儿童的康复需求。[①] 各级康复中心同时也是听力与语言康复救助服务的执行机构。截至 2024 年 3 月，残联系统内备案注册的听力语言康复相关机构的数量已超过 1.1 万家（含民营）。

成人语言康复服务主要由公立康复机构提供。由于语言障碍需要小班或一对一的个性化康复服务，对场地要求较高，而公立康复机构的场地、人员资源有限，所以大量的儿童语言康复服务主要由民营康复机构提供。

2024 年，全国共有特殊教育学校 2396 所，在校生 91.59 万人。全国共有特殊教育专任教师 8.13 万人，[②] 为视障、听障、语障、智障儿童的语言康复训练和盲文、手语教育提供了有力支撑。

通过“企查查”检索（截至 2025 年 7 月），处于存续、在业状态的语言康复训练相关企业共 826 家（不含分公司），注册资本总量 72.7 亿元；广东、北京、上海、江苏、福建等地聚集度相对较高，与当地社会经济发展程度呈正相关。其中，语言康复训练机构占比 88%，语言康复训练仪器设备研发生产企业占比 12%。

① 《为让听障群体实现“有声”梦想，这里正在做三件事》，中国残疾人联合会，2025-04-03，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1828392815779592477。

② 《2024 年全国教育事业发展统计公报》，中华人民共和国教育部，2025-06-11，http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202506/t20250611_1193760.html。

中国知网 https://www.cnki.net

四、中国语言康复业的产值分析

（一）助听器与人工耳蜗

助听器市场规模与年度需求量、实际销售的台单价密切相关。年度需求量又与人口数量、听力损失发生率、产品渗透率、产品生命周期、产品复购率、双耳验配率等因素密不可分。据智研咨询提供的行业报告，2023年中国助听器市场规模为66.61亿元，同比增长2.6%。[①] 又据中研普华提供的行业报告，2023年中国助听器市场规模已达71.3亿元，同比增长9.8%；预计到2025年，中国助听器市场规模有望达到80.7亿元，甚至更高。[②]

人工耳蜗市场规模与先天性耳聋发生率、人工耳蜗植入率、产品生命周期和销售价格直接相关，与社会救助政策也密切关联。根据Frost & Sullivan公司研究报告，2020—2025年，中国人工耳蜗植入量和销售额由9219例、6.5亿元增加至22 922例、15.38亿元，年度复合增长率分别为20.7%和18.8%；到2030年，市场规模将增长至43 159例、28.25亿元，年度复合增长率分别为13.5%和12.9%（中国医疗器械行业协会2022）。

（二）手语、盲文服务产品及其他信息交流辅助设备

目前，尚未发现这方面可资参考的行业报告和统计资料。据路亿市场策略（LP Information）分析报告，2024年全球盲人屏幕阅读器市场规模约为2.06亿美元，预计2031年达到2.78亿美元。[③] 又据头豹研究院数据，2018—2022年，中国言语障碍康复设备市场规模由2.53亿元增至2.9亿元；预计2023—2027年，将由2.94亿元增至3.09亿元，年复合增长率达1.27%。[④] 尽管目前难以分析国内这方面产品市场规模的总体状况，但可参照上述数据做出粗略估判，以个人用户为主（C端市场）的手语服务产品、盲文服务产品、辅助交流仪器设备，以及主要面向机构用户（B端市场）的语言康复训练仪器设备的市场规模，应已达到数十亿元级位（在10亿元至99亿元区间）。

（三）语言康复训练

语言康复训练是以全部或部分恢复语言障碍者基本语言能力为目的的语言康复医疗服务。自闭症、脑瘫、唇腭裂、语言发育迟缓主要发生在儿童期，儿童是市场化、营利性语言康复训练的主要客户。语言康复训练市场规模主要涉及儿童患者和营利性机构，不包括特殊教育学校、公立医疗与康复机构。语言康复训练的接受者大多来自城镇。

据笔者业内访谈，因城市、师资（语言康复治疗师）、患者类型等的不同，语言康复训练的费用在每课时60元至680元之间，语言康复训练周期通常需要3个月至两年；保守测算，设定平均课时费用为150元，取半年为平均周期，则平均每人费用为3万元。经综合测算，目前在民营机构接受语言康复训练的自闭症、脑瘫、语言发育迟缓、唇腭裂、植入人工耳蜗等语障患者（以儿童为主）在30万人左右，年度市场规模在90亿元左右。

---

① 《中国助听器行业市场运行动态及投资前景预测报告》，智研咨询，2024-06-28，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1802997072778927384&wfr=spider&for=pc。

② 《2025中国助听器行业市场规模及竞争格局、未来趋势预测分析》，中研普华，2025-04-01，https://www.chinairn.com/news/20250401/175912768.shtml。

③ 《全球盲人屏幕阅读器增长趋势2023—2029》，路亿市场策略，2023-07-29，https://www.lpinformation.com.cn/reports/218450/screen-readers-for-blind。

④ 《言语障碍康复设备》，头豹研究院，2023-10-29，https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=6527a5ec99d8b746e22536a4。

中国知网 https://www.cnki.net

公立机构中的语言康复训练，以脑卒中引起的失语症、构音障碍成年患者为主要服务对象。《中国脑卒中防治报告（2023）》显示，中国40岁及以上人群脑卒中患者达1242万，每年新发病330万人。流行病学报告指出，脑卒中后有21%—38%伴有言语障碍（明跃，等2014），经过语言康复训练，有50%—60%语言功能可恢复（权晓燕，孙淑燕2005）。保守估计，目前在公立机构中接受语言康复训练的患者在60万人左右，年度市场规模在60亿元左右。

综上所述，目前中国语言康复业年度市场规模超过300亿元。这一规模与美国相比，有着巨大差距，美国仅语言治疗服务的营收总额在1999年就达到了300亿美元（廖敏，高立群2017）。

五、中国语言康复业发展的路径选择

（一）健全与完善语言康复的行业认知，整合资源，推动全行业高质量发展

语言康复业是语言产业与大健康产业的交集。在中国国民经济行业分类中，语言康复业主要分布在制造业、教育行业、卫生和社会工作、批发和零售业等4个门类，涉及的中类、小类有康复辅具制造、特殊教育、医院等医疗机构、康复辅具适配服务、医药及医疗器材批发与零售等。基于残疾和语言障碍分类，产生不同类别的语言障碍患者，构成语言康复需求端；语言康复业各细分行业对应于各种语言障碍类别，向需求端的语言障碍患者提供相应的语言康复产品与服务，构成产业供给端；政府系统及相关部门、事业单位、社会组织向语言康复需求端和产业供给端提供公共服务，构成事业供给端。三者形成供需链条，从而构成语言康复业的完整生态系统（见图2）。

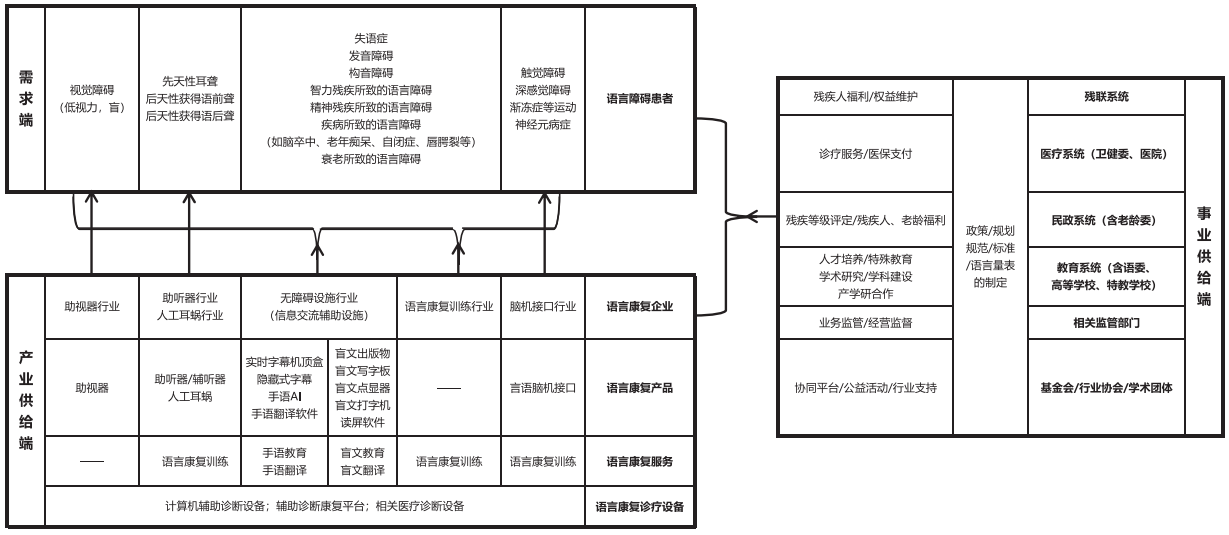

图2　语言康复业生态系统

长期以来，语言康复领域聚焦于听力与言语康复，也涵盖因身心疾病所致语言与交流障碍的语言康复，但不大涉及视障盲人语言能力缺失的弥补和盲文训练。从语言能力、语言障碍、语言康复的完整意义和大健康的视野出发，应该重塑语言康复行业认知，突破传统听力与言语康复行业界限，全口径建设语言康复体系，集医疗康复服务、教育康复服务为一体，统合包括语言障碍诊断与评定、助视器、助听器、人工耳蜗、手语服务、盲文服务、信息交流辅助设备、语言康复治疗与训练等行业，形成全行业合力。构建大语言康复业，以此规划语言康复产业发展，全口径进行语言康复业的经济统计与运作。

中国知网　https://www.cnki.net

中国的语言康复机构包括公立和民营两种性质。公立机构分属残联、医疗、教育三大系统。这些不同隶属关系的语言康复供给主体，“在成立时没有统一的审批与审核，机构性质不同，职责不明确，收训能力与师生配比没有明确规定，在开展听力语言康复工作时带来许多问题”（宋蕾 2014）。如此分散的社会资源，只有通过有效整合，在事实和建制上形成一个有活力的整体行业，才能够理顺关系，使与发展相关的所有问题一一找到解决门径。对这些机构如何进行协调和有效管理，关系到整个语言康复业的可持续发展。政府可以授权或法定相关部门作为语言康复行业的统筹协调机构，或成立语言康复行业协会，以对语言康复业发展的共识为基础，整合各方力量，促进解决语言康复业发展的理念与规划、学科建设和人才培养、行业规范与标准、行业的科学管理模式等问题。

（二）健全与完善语言康复人力资源体系，扩大供给，满足日益增长的语言康复需求

国际上，语言治疗师的需求量标准是每 10 万人 20 名，听力师的需求量标准是每 10 万人 5 名。按此标准，中国内地至少需要语言治疗师 28 万名、听力师 7 万名。中国在岗语言治疗师不足 1000 名，在岗听力师不足 600 名，聋儿特殊教育教师约 4000 名，加上民营机构可开展语言康复训练的教师 10 000 余名，远远不能满足数千万听力与语言障碍患者的需求（陈艳，等 2018）。《中国残疾人事业统计年鉴（2023）》（中国残疾人联合会 2023）数据显示，截至 2023 年底，中国共有听力言语康复在岗人员 18 444 人，其中业务人员 11 899 人。聋儿语训教师、特殊教育教师包括在内，在岗听力与语言康复从业者仅 10 万余人，即便如此宽口径统计，人才缺口也达 10 余万。中国受语言障碍影响的人群数量巨大，而语言治疗师却远远不能满足最低的人均需求，亟待解决这一难题（石定栩 2020）。

美国、澳大利亚、英国等国，将语言治疗师纳入“循证—实践—研究”一体化的高等教育体系，并通过立法确立硕士准入、国家考试与持续注册制度，中国 SLP 在制度、标准、课程、师资、监管等方面存在显著差距。美国于 2008 年起终止了听力学硕士培养，转向本科毕业后的 4 年制临床听力学博士培养。目前听力学专业已通过美国教学认证委员会资格认证的大学有 75 所，招生总数为 2400 名。美国有 310 所大学开设言语–语言病理学本科专业，其中 232 所设有硕士研究生教育（陈颖，等 2023）。相比之下，中国相关专业教育起步晚（20 世纪末）且规模小。在中国听力与言语康复学本科教育中，各院校课程设计、教学大纲与培养方案尚不统一，学生实习环节的质量与成效差异较大。人民政协网有文章称：“中国是世界上听力障碍人数最多的国家，但中国却是听力服务专业人员极度匮乏的国家。目前中国全国只有 1 万名左右的听力健康专家，配给水平不足美国的 7%。”[①] 在中国职业资格制度中，虽然有助听器验配师、听力师、听觉口语师等 3 个职业进入了《中华人民共和国国家职业分类大典（2022 年版）》，但职业资格认证并不健全，特别是语言治疗师或语言康复师职业身份、职业名称都还未予以明确。可见，中国语言康复领域相关学科专业人才、职业岗位人才的供需缺口巨大，发展任重道远，亟须采取措施，建构数量与质量能够满足全社会语言康复需求的专业人才供给体系，包括语言康复学科与人才培养体系、语言康复职业资格认证体系等，加快缩小供需差距。2024 年 5 月，教育部正式批准设立“康复大学”，该校将建构多学科交叉融合的“大健康”学科专业体系，示范引领中国康复学科发展。

（三）健全与完善语言康复福利政策，加大力度，重构语言康复社会保障机制

根据世界卫生组织发布的《世界听力报告》（2021），听力损失发生率在新生儿期为 0.2%，1—4

① 《我国每 13.7 万人才拥有一位听力专家，不足美国的 7%》，人民政协网，2017–05–06，https://www.rmzxw.com.cn/c/2017-05-06/1521105.shtml。

中国知网 https://www.cnki.net

岁时增至 1.0%，10—14 岁时增至 1.7%，而 15—19 岁时则高达 1.9%。中国听障人群达 2780 万人，每年新增听力损失儿童 2 万余名。在中国为数庞大的语言障碍人群中，能拥有语言康复辅助器具和接受语言康复训练的，还只是其中的部分人群。例如，助听器、人工耳蜗的产品渗透率分别仅为 5%、0.2%，即在对助听器、人工耳蜗有配备需求的人员中，满足率分别是 1/20 和 1/500；又如，儿童语言发育迟缓的语言康复训练渗透率不足 4%。面对数千万人的各类需求存量，出于价格较为昂贵、政策覆盖面不足等原因，语言康复服务供给仍存在巨大缺口，多数患者无法获得早期干预和康复服务。语言康复业的特殊性决定了不可将其完全交给市场，需要从福利援助、医保项目、健康教育等方面创新制度设计，在扩大供给总量的同时，加大对城乡困难家庭的帮扶力度，关注偏远地区的语言康复机构建设，提高农村地区的服务可及性，保障农村地区患者也能得到及时筛查、诊疗和康复服务。

目前，一些费用较为昂贵的语言康复辅具（如助听器、人工耳蜗），以及更多的语言康复训练项目，未被纳入全民医保，低收入家庭、农村地区患者自行承担的压力较大。当前，纳入医保的康复项目数量少且支付比例低，是语言康复行业供给不足、需求意愿抑制、消费行为受阻、供需差距巨大的关键卡点之一。以助听器为例，与高福利保障国家相比，中国存在明显不足，主要体现在：（1）医保介入浅。法国、德国、日本均实现医保直付，患者零垫付。（2）成人保障薄弱。丹麦、新加坡实行“全民低门槛 + 终身额度”，自付上限可控。（3）65 岁以上老年听障者尚无全国统一补贴。丹麦、法国、新加坡将老年人群纳入常规补贴周期。中国需要创造条件，根据国情进一步扩大康复医疗医保支付项目覆盖面，创新医保支付方式，制定服务儿童、劳动年龄、老龄等各生命周期人群的针对性政策，实现从“兜底保障”向“全民适度保障”升级，满足多样化、差异化的语言康复需求。

2025 年全国两会召开之际，中国残疾人联合会主席程凯表示：“要在助残领域培育和发展新质生产力，努力将残疾人购买各类辅助器具和家庭无障碍改造纳入消费品以旧换新补贴范围，以科技创新带动残疾人服务业规模升级。”[①] 建议建构面向语言障碍重度患者的康复救助制度，以应帮尽帮、应补尽补为目标，加大医保力度，引导和激发全社会语言康复消费需求。

（四）加强语言康复科技产品研发，打造智能化产品，形成具备竞争力的国产品牌

人工智能技术的应用，使语言康复产品（服务）智能化。传统的言语康复需要康复教师与患者面对面进行，而基于大数据的 AI（人工智能）言语康复平台，可以解决康复教师经验水平的局限性，使康复功能评估更具科学性，康复训练更具规范化、有效性。可穿戴设备可以实时监测，并实时给出评估与治疗、康复建议，如采用人工智能技术的可穿戴式“人工喉”，帮助失语者恢复语言交际功能。在听力康复方面，AI 的应用主要体现在听力检测、诊断及智能助听器产品等方面，双耳均有听力损失者在选配助听器时，智能助听器可以通过各种近场无线技术，实现耳际之间的链接和大脑听觉信息真正的中枢融合。助听器 3D 打印、助听器远程调试、耳鸣康复 APP（移动应用程序）等都离不开 AI 的贡献（D. Jiang，赵旭 2014）。近期，基于脑机接口的智能神经调控在言语康复方面取得了显著进展，虽尚未进入临床应用，属于未来产业，但需要积极跟踪技术进步，蓄势发展。总之，计算机和人工智能技术的应用，可以明显提高语言康复的诊治效率和效果，弥补语言治疗师数量不足，改善语言康复服务供需不平衡的情况。未来定有更多的智能产品，帮助语言障碍人群的康复和无障碍生活。

① 《生活有保障　生命有尊严　未来有希望——专访全国政协常委、中国残联主席程凯》，https://www.cdpf.org.cn/xwzx/clyw2/15505ad307b64ef09ef764cbbb27daa0.htm。

中国知网　https://www.cnki.net

六、结　语

语言康复是康复医疗体系和语言产业的重要组成部分。随着需求端语言康复意识的觉醒，语言康复消费正在从基础传统的诊疗康复方式向进阶升级的个性化消费发展。在人口老龄化加速、国民语言健康意识增强、国家福利政策改善的背景下，语言康复业市场规模将持续增长，市场未来成长空间可达数千亿元。①

随着无障碍理念的发展、数智时代的到来，语言康复业也会有很多新产品、新内容、新要求，语言康复业的相关方、相关场域在不断外扩，更加需要社会的关注与参与，包括社会效益和产值。保障每个人“听”与“说”的权利，亦即保障公民的语言权益；在信息时代，这也是获取信息的权利，是基本人权。智能化和无障碍理念，是语言康复业发展的两大助力。

语言康复从医学治疗，到教育增能，未来再发展到无障碍的社会生活和信息获取。语言康复的事业、视野、涉及人员的场域、社会效益与社会责任等都在发展中，值得研究，也将引发新的社会理念和社会行动。语言是人类进步的“脚手架”，语言能力是人类个体利用语言做事情、求发展的能力，不完全是听说读写译。故而语言能力的康复，早年是语言的基本能力的康复，之后发展到“以言行事”的能力康复。“以言行事”是现在和未来语障人群康复的新目标。应基于大健康理念，健全与完善面向全人群、全生命周期的语言康复体系。语言健康是国民健康的重要方面，“人人享有语言健康”应该成为社会共识和“健康中国”建设目标，并将这一理念和目标体现在新时代的语言产业规划中（李艳 2023）。

参考文献

陈　艳，王　璇，胡　楠，等　2018《国内外语言治疗师培养现状及本科教育课程设置比较》,《中华物理医学与康复杂志》第9期。

陈　颖，延江健，吴斯莹，等　2023《我国听力与言语康复学专业本科教育理论学习及实习现状调查》,《中国听力语言康复科学杂志》第5期。

程　凯　2007《听障儿童语言康复对策研究》，山东大学博士学位论文。

顾曰国　2019《老年语言学发端》,《语言战略研究》第5期。

郭志强　2022《中国助听器渗透率不足5%，国外巨头争相涌入，背后的市场逻辑是什么》,《中国经济周刊》第11期。

贺宏志　2013《语言产业引论》，北京：语文出版社。

黄立鹤，车伊然　2024《人工智能技术赋能老年语言学的发展与思考》,《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》第5期。

D. Jiang，赵　旭　2014《影响听力学未来的五大关键词》,《中国听力语言康复科学杂志》第3期。

李　艳　2017《基于语言服务视角的语言康复行业状况及对策研究》,《语言政策与规划研究》第1期。

李　艳　2023《新时代语言产业规划研究》,《昆明学院学报》第4期。

李　艳，汪梦尧　2024《语言产业视野下老年语言康复产品和服务供需现状与供给对策研究》,《南宁师范大学学报（哲学社会科学版）》第1期。

李宇明　2022a《构建信息无障碍社会》,《语言战略研究》第2期。

李宇明　2022b《无障碍社会的语言之功》,《语言战略研究》第5期。

① 前文所述，在对助听器、人工耳蜗有配备需求的患者中，目前的满足率分别是1/20和1/500，儿童语言发育迟缓的语言康复训练渗透率不足4%。若实现供需平衡，目前300亿元的市场规模将至少有数十倍的成长潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

廖　敏，高立群　2017《美国语言康复业快速发展的法规保障及其启示》,《语言战略研究》第 5 期。
刘晓宇　2024《关于中国语言障碍者语言政策的调查研究》，东北师范大学博士学位论文。
马　文，刘青松　2023《语言科学研究助力国家健康治理：理据与路径》,《外语电化教学》第 3 期。
马　文，刘青松，代学群　2025《语言与健康研究近二十年概观及国际前沿动向》,《现代外语》第 2 期。
明　跃，徐峻峰，杨丽华　2014《言语训练配合音乐疗法治疗 Broca 失语一例》,《中国听力语言康复科学杂志》第 1 期。
权晓燕，孙淑燕　2005《脑卒中患者的康复护理》,《中华现代护理学杂志》第 12 期。
单春雷　2021《语言康复学》，北京：人民卫生出版社。
石定栩，杨　洋　2020《中国语言障碍与言语治疗——现状分析和发展思路》,《语言战略研究》第 2 期。
宋　蕾　2014《陕西省听障儿童听力语言康复机制运行问题》,《陕西广播电视大学学报》第 2 期。
孙喜斌，魏志云，于丽玫，等　2008《中国听力残疾人群现状及致残原因分析》,《中华流行病学杂志》第 7 期。
滕延江　2022《论老年语言福利体系的构建》,《语言战略研究》第 3 期。
王　欢　2021《语言病理学发展概述》,《黑龙江科学》第 23 期。
张凌云　2021《语训师难寻》,《文摘报》11 月 4 日第 02 版。
中国残疾人联合会　2023《中国残疾人事业统计年鉴（2023）》，北京：中国统计出版社。
中国听力医学发展基金会　2021《中国听力健康报告（2021）》，北京：社会科学文献出版社。
中国医疗器械行业协会　2022《我国人工耳蜗市场现状及发展趋势》，载王宝亭，耿鸿武《中国医疗器械行业发展报告（2022）》，北京：社会科学文献出版社。
周德宇，黄立鹤，杨晶晶　2020《老年语言学研究的时间维度：毕生发展与生命历程》,《浙江外国语学院学报》第 5 期。
周德宇，张　惟　2021《语言与健康的关系：标记、媒介与资源》,《语言战略研究》第 5 期。
朱祖德，张　强，杨亦鸣　2020《中国临床语言学学科内涵与科学架构》,《语言科学》第 6 期。

责任编辑：魏晓明

致　谢

2025 年第 6 期收官，《语言战略研究》走完 10 年里程。如今语言生活研究蔚成大观，但是，却顾来径，筚路蓝缕。幸得国家语委指导、编委鼎力支持和作者不吝赐稿，乃有所成，衷心感谢。

2026 年第 1 期，是新征程的第一步。一元复始，万象更新。李宇明教授担任名誉主编，郭熙教授担任主编。编委会完成换届，数位老编委荣退，增添若干青年学者。谨此向李宇明主编和荣退编委致以崇高的敬意，并热烈欢迎新晋编委！为了及时反映语言生活新现象、深入讨论语言生活新问题，我刊还将以前的“语言跨界谈”和“专题研究”中的“多人谈”合并为新栏目“××（问题）× 人谈”。

期待学界继续支持，扶助《语言战略研究》更上层楼。

《语言战略研究》编辑部

中国知网　https://www.cnki.net